

Sujet : 23 Les dyslipidémies

1. Les PCSK :
 - A- sont des convertases
 - B- se lient au récepteur des apoprotéines B
 - C- favorisent l'expression des récepteurs des LDL
 - D- peuvent être stimulés par les médicaments
 - E- peuvent être la cible des mutations
2. Le métabolisme du cholestérol dépend de:
 - A- insuline
 - B- cortisol
 - C- thyroxine
 - D- GH
 - E- oestrogènes
3. Le syndrome métabolique comporte une élévation de:
 - A- TG
 - B- HDL-cholestérol
 - C- LDL-cholestérol
 - D- pression artérielle
 - E- tour de taille
4. Les LDL s'incrustent dans la plaque vasculaire en cas de:
 - A- oxydation
 - B- estérification
 - C- taille petite
 - D- densité élevée
 - E- récepteur Apo B fonctionnel
5. Les dépôts d'esters de cholestérol peuvent se déposer dans :
 - A- les parois vasculaires
 - B- les articulations
 - C- les tendons
 - D- les paupières
 - E- le foie
6. L'hyperlipoprotéïnémie la plus rare est le type :
 - A- I
 - B- II a
 - C- II b
 - D- III
 - E- IV
7. Le syndrome métabolique entraîne :
 - A- une hyperproduction de VLDL
 - B- des lipoprotéines de grande taille
 - C- des lipoprotéines de densité élevée
 - D- des lipoprotéines oxydées
 - E- un HDL-cholestérol bas
8. Un sérum trouble à jeun est rencontré au cours de l'hyperlipoprotéïnémie de type :

- A- I
- B- IIA
- C- IIB
- D- III
- E- IV

9. L'hypercholestérolémie familiale:

- A- est transmise selon la loi mendélienne
- B- entraîne un sérum à jeun clair
- C- peut être due à 3 mutations
- D- élève les VLDL
- E- est traitée par les statines

10. Chez un patient âgé de 32 ans qui présente à la suite d'un IDM une hypercholestérolémie avec une hypertriglycéridémie, un sérum trouble à jeun, une bande large à l'électrophorèse des lipoprotéines englobant les bêta et les pré bêta, vous retenez une hyperlipoprotéinémie de type:

- A- I
- B- II a
- C- II b
- D- III
- E- IV

11. Une baisse du HDL-cholestérol peut être entraînée par:

- A- une résistance à l'insuline
- B- le tabagisme
- C- le déficit en LCAT
- D- le déficit en PCSK-9
- E- l'hypothyroïdie

12. L'évaluation du risque vasculaire tient compte de:

- A- l'état hépatique
- B- l'état diabétique
- C- de la prise d'alcool
- D- la fonction rénale
- E- l'état cardiaque

13. Les dépôts d'esters de cholestérol peuvent se déposer dans:

- A- les parois vasculaires
- B- les articulations
- C- les tendons
- D- les paupières
- E- le foie

14. Le score de l'ESC est basé sur:

- A- l'âge
- B- le tabac
- C- le diabète
- D- le non HDL cholestérol

E- la fonction rénale

15. Un risque vasculaire élevé correspond à:

- A- une microalbuminurie isolée
- B- une hypercholestérolémie familiale
- C- un diabète avec une atteinte de 3 organes cibles
- D- un diabète de type 1 âgé de plus de 40 ans
- E- des antécédents d'IDM

16. Les fibrates sont indiqués en cas de:

- A- hyperlipoprotéinémie de type I
- B- hyperlipoprotéinémie de type IV
- C- hyperlipoprotéinémie de type V
- D- hyperlipoprotéinémie de type II a
- E- le risque résiduel

17. Le risque musculaire des statines est majoré par:

- A- l'âge avancé
- B- l'hypothyroïdie
- C- l'association aux fibrates
- D- le diabète déséquilibré
- E- l'association à l'ézétimibe

Cas clinique1

Un patient âgé de 16 ans, consulte pour des xanthomes cutanés.

Son exploration montre un cholestérol total à 12 g/l, un HDL-cholestérol à 0,6 g/l et des triglycérides à 1,4 g/l.

18. Cet état métabolique doit faire rechercher :

- A- un diabète sucré
- B- une hypothyroïdie
- C- un hypercorticisme métabolique
- D- un syndrome néphrotique
- E- une cholestase

Cette exploration est négative. L'interrogatoire trouve la présence des mêmes troubles chez ses 2 parents consanguins.

19. Vous évoquez une mutation du gène de:

- A- la lipoprotéine lipase
- B- la LCAT
- C- PCSK-9
- D- récepteur apoprotéine B
- E- HMG CoA réductase

20. On pourra traiter ce patient par:

- A- plasmaphérèse
- B- statines
- C- fibrates
- D- metformine

E- inhibiteurs PCSK-9

Cas clinique 2

Un patient diabétique âgé de 56 ans est traité par ADO depuis 3 ans.

Son exploration montre: IMC: 35; TA: 150/100 mmHg; fond d'œil normal; micro-albuminurie: 25 mg/j; clearance de la créatinine: 75 ml/mn; ECG normal; cholestérol total: 2,5 g/l; HDL-cholestérol: 0,3 g/l; triglycérides: 5 g/l

21. Son taux de LDL-cholestérol est:

- A- 1,5 g/l
- B- 1,7 g/l
- C- 1,9 g/l
- D- 2,1 g/l
- E- 2,3 g/l

Sous mesures hygiéno-diététiques et 40 mg d'atorvastatine, il présente un IMC à 34; HbA1c: 7%; LDL-cholestérol à 0,6 g/l et des triglycérides à 3,5 g/l, TSH à 1,5 mUI/l

22. Son état peut s'améliorer si:

- A- on le fait maigrir
- B- on lui prescrit de la thyroxine
- C- on lui prescrit des fibrates
- D- on augmente la dose d'atorvastatine
- E- on associe de l'ézétimibe

Sous mesures hygiéno-diététiques et 40 mg d'atorvastatine, il présente un IMC à 34; HbA1c: 7%; LDL-cholestérol à 0,6 g/l et des triglycérides à 3,5 g/l, TSH à 1,5 mUI/l

23. Son état peut s'améliorer si:

- A- on le fait maigrir
- B- on lui prescrit de la thyroxine
- C- on lui prescrit des fibrates
- D- on augmente la dose d'atorvastatine
- E- on associe de l'ézétimibe

24. Sous ce traitement elle présente un LDL-cholestérol à 0,7 g/l et des triglycérides à 2,5 g/l. vous décidez:

- A- de faire un contrôle dans un an
- B- augmenter la dose du médicament
- C- d'associer des oméga-3
- D- d'associer de l'ézétimibe
- E- d'associer des inhibiteurs PCSK-9

Cas clinique 3

Une patiente âgée de 25 ans, ayant une mère diabétique, ayant mené à terme 2 grossesses avec notion de macrosomie, sous contraception hormonale, présente la situation suivante:

IMC: 32; tour de taille: 93 cm; TA: 130/80 mmHg; HbA1c: 6%; cholestérol total: 1,5 g/l; triglycérides: 3,5 g/l, HDL-cholestérol: 0,2 g/l; micro-albuminurie: 20 mg/j; TSH: 2 mUI/l

25. Cette patiente présente une dyslipidémie de type :

- A- I
- B- II a
- C- II b
- D- IV
- E- V

26. Cette dyslipidémie est secondaire à:

- A- hypothyroïdie
- B- diabète sucré
- C- sa contraception
- D- son obésité
- E- sa néphropathie

27. Cette patiente devra éviter:

- A- les sucres simples
- B- les graisses insaturées
- C- les graisses saturées
- D- les anti oxydants
- E- les fibres

28. Sous ces mesures, elle présente un LDL-cholestérol calculé à 0,8 g/l et des triglycérides à 1,4 g/l. vous décidez de:

- A- prescrire des fibrates
- B- prescrire une statine
- C- prescrire la thyroxine
- D- réaliser un contrôle dans un an
- E- prescrire la metformine

Cas clinique 4

Une patiente âgée de 20 ans, présente la situation métabolique suivante:

IMC: 24; TA: 110/70 mmHg; cholestérol total: 1,5 g/l; triglycérides: 11 g/l et HDL-cholestérol: 0,5 g/l; aspect du sérum à jeun lactescent avec un surnageant à l'épreuve de décantation.

29. Cette patiente présente une dyslipidémie de type :

- A- I
- B- II a
- C- II b
- D- III
- E – IV

30. Cette dyslipidémie est en rapport avec une mutation du gène de:

- A- apoprotéine B
- B- PCSK-9
- C- apoprotéine C
- D- lipoprotéine lipase
- E- récepteur apoprotéine B

31. Cette patient court un risque de survenue de:

- A- diabète pancréatique
- B- IDM
- C- AVC
- D- pancréatite aigue
- E- xanthome éruptif

Cas clinique 5

Une patiente âgée de 35 ans diabétique de type 2 a un risque vasculaire estimé à 4%.

Son exploration métabolique montre: IMC: 31; TA: 120/80 mmHg; HbA1c: 5%; cholestérol total: 1,8 g/l; HDL-cholestérol: 0,4 g/l triglycérides: 2 g/l

32. Son taux de LDL-cholestérol est:

- A- 0,8 g/l

- B- 1 g/l
- C- 1,2 g/l
- D- 1,4 g/l
- E- 1,6 g/l

33. Cette patiente devra éviter:

- A- les sodas
- B- les fruits
- C- les fruits secs
- D- les poissons gras
- E- le beurre

34. Les prescriptions envisagées chez cette patiente sont:

- A- metformine
- B- simvastatine
- C- rosuvastatine 5 mg
- D- fénofibrate
- E- atorvastatine 10 mg

Cas clinique 6

Un patient âgé de 35 ans présente un diabète de type 1 depuis 15 ans, traité par insuline

Pas de tabagisme mais boit de l'alcool

Sur le plan clinique: IMC à 22; TA: 120/80 mm Hg; loge thyroïdienne libre

35. HbA1c: 9%; LDL-cholestérol calculé à 2 g/l; triglycérides: 4 g/l; HDL-cholestérol: 0,4 g/l;

Son état lipidique est en rapport avec:

- A- un syndrome métabolique
 - B- un diabète déséquilibré
 - C- une néphropathie
 - D- une hypothyroïdie
 - E- la prise d'alcool
- micro-albuminurie: 24 mg/j; TSH: 10 mUI/l

36. Vous débutez le traitement de ce patient en prescrivant:

- A- de plus fortes doses d'insuline
- B- une statine
- C- un fibrate
- D- la thyroxine
- E- des IEC

Cas clinique 7

Un patient âgé de 52 ans présente un diabète de type 2 ancien de 5 ans, associé à une HTA, traité par des biguanides, IEC, cordarone

Il a bénéficié d'une revascularisation coronarienne il y a un an

Il fume 1 paquet par jour et boit de l'alcool

On trouve chez ce patient: IMC à 35, TA: 160/90 mm Hg; rétinopathie oedémateuse; loge thyroïdienne libre

Biologie: HbA1c 10%

37. Son état lipidique peut changer si:

- A- on le fait maigrir
- B- il équilibre son diabète
- C- il arrête de fumer
- D- il arrête de boire
- E- il équilibre sa TA

Après correction de ces facteurs, son bilan lipidique montre: cholestérol total: 2,5 g/l;
triglycérides: 2 g/l; HDL-C: 0,3 g/l

38. Son taux de LDL-cholestérol est:

- A- 2 g/l
- B- 1,9 g/l
- C- 1,8 g/l
- D- 1,7 g/l
- E- 1,6 g/l

39. Sous 40 mg d'atorvastatine, il présente un LDL-cholestérol à 0,9 g/l et des triglycérides à 2 g/l. Que décidez-vous ?

- A- associer un fibrate
- B- augmenter la dose d'atorvastatine
- C- associer l'ézétimibe
- D- associer la thyroxine
- E- garder la même dose

40. Sous ce traitement, il présente un LDL-cholestérol à 0,5 g/l et des triglycérides à 2,5 g/l. vous décidez d'associer:

- A- ézétimibe
- B- gemfibrozil
- C- inhibiteur PCSK-9
- D- fénofibrate
- E- oméga-3

41. Sous ce traitement, le patient signale des douleurs musculaires. Vous décidez de doser :

- A- la TSH
- B- les CPK
- C- le LDL-cholestérol
- D- la clearance de créatinine
- E- le taux de prothrombine